Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - (53) 99979-2839 - Email: frpelotas3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5030506-40.2023.8.21.0022/RS

AUTOR: ROSANE MACHADO ALBERNAZ ARAUJO

RÉU: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

SENTENÇA

ROSANE MACHADO ALBERNAZ ARAUJO, já qualificada, ajuizou ação ordinária para fornecimento de fármaco com pedido de antecipação de tutela, em desfavor de **UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS**, por igual qualificada, alegando, em síntese, que se encontra tratando de Neoplasia Maligna de Língua (CID: C02), estágio clínico IV, com diagnóstico desde setembro de 2021, sendo que, para tanto, já realizou tratamento cirúrgico e radioterapia. Todavia, relatou que recentemente, progrediu em região cervical com doença irresecável e não mais passível de tratamento, com indicação de tratamento paliativo. Disse que, como já realizou tratamento associado a imunoterapia, indicaram-lhe o tratamento com quimioterapia associada aos fármacos Docetaxel, Cisplatina e Cetuximabe. Asseverou que não possui condições de custear o medicamento, vez que, para uso contínuo, o orçamento de menor valor mensal seria de R$13.208,11, sendo portanto, encaminhada solicitação dos medicamentos à ré, que negou sob o argumento de que se tratam de medicações não cobertas pelo rol de procedimentos da ANS. Pugnou, em sede de tutela de urgência, seja determinado à ré a realização do tratamento prescrito e, como tutela definitiva, a confirmação da tutela liminar. Pediu a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1).

Foi concedido o benefício da gratuidade judiciária e deferido o pedido de tutela de urgência (evento 3).

A ré foi citada (evento 7), e apresentou contestação no evento 9, alegando que os medicamentos tiveram cobertura negada visto que o pedido de liberação não possui cobertura contratual, já que ausente previsão para medicamentos experimentais. Salientou que não consta indicação de tratamento para a patologia que acomete a autora na bula dos fármacos. Ainda, destacou que a cobertura do plano de saúde está expressamente vinculada ao Rol de Procedimentos Médicos da ANS, com limitação de cobertura de procedimentos, os quais carecem de comprovação acerca de sua efetividade e segurança. Defendeu que o pedido foi submetido à análise técnica da Auditoria Médica, que concluiu que o uso do medicamento na situação apresentada diverge da finalidade para o qual foram prescritos e autorizados pela ANVISA. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica no evento 15.

Restou invertido o ônus da prova e determinada a intimação das partes para dizer sobre o interesse na produção de outras provas (evento 17), sendo que a parte autora quedou-se inerte (evento 21), ao passo que a ré postulou o julgamento antecipado da lide (evento 24).

Veio o processo concluso para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito tramitou regularmente, não havendo quaisquer nulidades a serem declaradas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes preliminares para desate, procedo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação de a ré arcar, ou não, com os custos do tratamento paliativo da requerente através de quimioterapia associada aos medicamentos Docetaxel, Cisplatina e Cetuximabe

E, no caso, tenho que cabível a condenação da ré a arcar com o tratamento solicitado pelo médico da autora, confirmando-se a liminar outrora deferida.

Com efeito, se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor nos termos do verbete da Súmula nº 469 do STJ, segundo a qual: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesse passo, aplicável ao caso em tela o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a interpretação de forma mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas do contrato.

Dito isso, entendo que a negativa da ré não se sustenta.

A uma, porque não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento.

Ao depois, porque cabe ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado para o seu paciente, ainda mais que, no caso, o tratamento convencional não teve a resposta positiva necessária, ocasionando a progressão da doença.

Assim, sendo incontroversa a existência da doença e o requerimento do médico assistente da autora, no sentido da necessidade dos medicamentos, não prevalece a negativa deduzida.

Sobre o tema, já decidiu o TJRS:

*APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE MEDICAMENTO. N**EOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE. COBERTURA DEVIDA.** FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. TUTELA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA. DA NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA 1. NO CASO EM EXAME, A PARTE AUTORA PRETENDIA QUE A RÉ FOSSE CONDENADA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LYNPARZA (OLARIB_ 150 MG, DE FORMA CONTÍNUA, OU O VALOR CORRESPONDENTE PARA SUA AQUISIÇÃO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE), POIS FOI DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO (CID C56.9), NECESSITANDO REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM O MEDICAMENTO SOLICITADO PELO SEU MÉDICO, UMA VEZ QUE TODAS AS OPÇÕES DISPONÍVEIS APRESENTAM RESULTADOS INFERIORES, TANTO NO QUE TANGE TOXICIDADE, TEMPO DE CONTROLE DA DOENÇA, MAS SOBRETUDO EM TEMPO DE VIDA DE PACIENTES COM MUTAÇÃO DE BRCA. 2. DIANTE DO ATESTADO NO QUAL FOI RESSALTADO PELO MÉDICO ASSISTENTE A URGÊNCIA PARA INÍCIO DO TRATAMENTO, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CASO, FOI CONCEDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELA MAGISTRADA SINGULAR, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO EVENTO 4 DO PROCESSO ORIGINÁRIO, SENDO MANTIDA A DECISÃO EM GRAU RECURSAL COM O JULGAMENTO DE IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. 3. ENTRETANTO, CONFORME SE PERCEBE NA PETIÇÃO ACOSTADA NO EVENTO 38 DOS AUTOS, HOUVE O FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA, SENDO JULGADO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. PORÉM, NO CASO EM ANÁLISE, É NECESSÁRIO O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (EVENTO 4), A FIM DE QUE HAJA A CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LIMINAR, RAZÃO PELA QUAL A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO 5. POSSIBILIDADE DE REEXAME AMPLO DA MATÉRIA TRATADA NO PRESENTE PROCESSO, NA FORMA DO ART. 1.013, §§ 1° E 3º DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ASSIM, O FEITO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER JULGADO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 355 DO CPC. DO JULGAMENTO DE PLANO DO FEITO 6. OS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ISTO É O QUE SE EXTRAI DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 35 DA LEI 9.656/98. SÚMULA N. 608 DO STJ. 7. NÃO CABE À DEMANDADA DETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE ESTA DECISÃO CABE AO MÉDICO QUE A ACOMPANHA, QUE NO CASO INDICOU O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REFERIDO **POR SER O MAIS ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES DO DEMANDANTE. 8. O ROL DE PROCEDIMENTOS PUBLICADO PELA ANS CONSTITUI APENAS UMA REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AINDA, AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELA ANS SERVEM COMO ORIENTAÇÃO, NÃO SENDO TAXATIVAS, DE MODO QUE DEVE SER OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. 9. ASSIM, DESCABIDA A NEGATIVA SECURITÁRIA POR PARTE DA DEMANDADA, POIS O QUE IMPORTA PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A DOENÇA APRESENTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.** 10. PORTANTO, DEVE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, DETERMINANDO A COBERTURA PELA DEMANDADA DO TRATAMENTO POSTULADO, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, AINDA QUE A AUTORA TENHA FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL RESTA PREJUDICADO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO APÓS O ÓBITO, DE FORMA QUE NECESSÁRIA A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PROCURADORA DA AUTORA QUE VISAVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 11. A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECORRE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA, MESMO MOMENTÂNEA, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE POBREZA OU MISERABILIDADE DA PARTE, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 98, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADO COM O ARTIGO 5º, LXXIV, DA CF. 12. A SITUAÇÃO FÁTICA EXAMINADA AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, EM FUNÇÃO DA PARTE APELANTE PERCEBER RENDIMENTO MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS, VALOR ESTE INSUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS GARANTIDAS CONSTITUCIONALMENTE E AS DESPESAS PROCESSUAIS. 13. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DEVE A RÉ ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, UMA VEZ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 14. VERBA HONORÁRIA FIXADA LEVANDO EM CONTA A NATUREZA DA CAUSA E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROCURADOR QUE ATUOU NO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA E JULGADO PROCEDENTE, DE PLANO, O PEDIDO INICIAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50005364620198210018, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-04-2021) [grifei].*

O tratamento concedido em sede de antecipação de tutela se mostra imprescindível para a boa terapêutica da autora, conforme expressamente elencado no laudo médico acostado no evento 1 (anexo laudo7), porquanto é portadora de Neoplasia Maligna de Língua (CID: C02), estágio clínico IV, necessitando fazer uso das medicações, a fim de manter a doença sem progressão, auxiliando na melhora da deglutição, a qual se encontra prejudicada e ainda, não menos importante, evitando o risco de vida da paciente.

Em que pese o tratamento experimental não estar previsto no rol de exigências mínimas estipulado no artigo 12 da Lei nº 9.656/98 e as cláusulas gerais do contrato contenham previsão de exclusão da cobertura, a patologia em si possui cobertura contratual, pelo que, considerando a imprescindibilidade do medicamento, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do Código Consumerista.

Nesse sentido, seguem precedentes do egrégio STJ, *sic*:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.

*1. **Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar.** Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1064435 / GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0044411-0, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 14/11/2017, Dje 23/11/2017.*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO

GENÉRICO. ART. 286, II, DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO ATACADA. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 333, I, DO CPC/73. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do CPC. 2. ***"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar"*** *(AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela licitude daapresentação de pedido genérico, entendendo tratar-se da hipótese prevista no inciso II do art. 286 do CPC/73. Tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283/STF.*

4. No que diz respeito ao artigo 333, I, do Código de Processo Civil, acrescente-se que os argumentos utilizados para fundamentar a pretensa violação somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas, o que encontra obstáculo na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 989137 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0252979-0. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017,Dje 08/09/2017.

Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos. Rejeição do primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente. Invalidade. (...) ***- Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.*** *(...)*

(REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010) (sem grifo no original)

Nesse mesmo sentido, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, *in verbis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. TROMBOFILIA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. COBERTURA DEVIDA. 1. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora. 2. Tendo em vista a verossimilhança do alegado pela parte agravante, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, imperioso o deferimento da medida antecipatória postulada*. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº70076027556, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018)*

SEGUROS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A negativa da cobertura de tratamento domiciliar, não encontra respaldo legal, uma vez que, nos termos da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde não podem excluir da cobertura medicamentos prescritos por médicos assistentes. Deve prevalecer a previsão de cobertura para a patologia em questão e não o local onde o tratamento será ministrado. *Deram parcial provimento ao apelo, por maioria, vencido Desembargador Ney Wiedemann Neto. (Apelação Cível Nº 70074462896, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 06/10/2017)*

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HEPATITE C. CIRROSE. TRATAMENTO DOMICILIAR. MEDICAMENTOS SOFOSBUVIR E DACLATASVIR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. *I. No caso, a beneficiária do plano de saúde, é portadora de hepatite crônica ativa, a qual evoluiu para cirrose, sendo que, por indicação da médica-assistente, necessitou de tratamento com a combinação dos medicamentos Sofosbuvir e Daclatasvir, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde. II. Contudo, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação.* ***De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. Nessa linha, não pode ser tolerada essa conduta abusiva das operadoras dos planos de saúde, tendo em vista que se o contrato não exclui o tratamento para a hepatite C e a médica que acompanha a paciente entende que os medicamentos Sofosbuvir e Daclatasvir são mais adequados para o tratamento, este deve ser coberto pelo convênio. III. Portanto, mostra-se abusiva a negativa de fornecimento dos medicamentos pela ausência destes na Resolução Normativa nº 338/2013, da ANS, e por ser de uso domiciliar.*** *IV. Redimensionamento da sucumbência, considerando o decaimento integral da ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071867816, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/03/2017)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNMED PORTO ALEGRE. TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. FORTEO (TERIPARATIDA). DEFERIMENTO A COBERTURA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR ESPECÍFICO E IMPRESCINDÍVEL PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COM PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. COBERTURA DEVIDA. *Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de procedência de ação de obrigação de fazer. Discute-se nos autos se faz jus a parte autora ao medicamento Forteo (teriparatida), prescrito para tratamento de osteoporose, cuja cobertura foi negada na via administrativa sob a alegação de inexistência de previsão contratual pra terapia via oral em ambiente domiciliar. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não oportunização da dilação probatória, em se tratando de matéria eminentemente de direito em que a prova mostra-se desnecessária para a solução do litígio. Ademais, em se tratando de prova documental, incumbem às partes instruírem a petição inicial e a contestação com os documentos aptos a demonstrar suas alegações, nos termos do art. 396 do CPC de 1973. COBERTURA CONTRATUAL -* ***A decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a demandada fornecesse o medicamento foi apenas confirmada na sentença, não tendo sido atacada mediante o recurso adequado, encontrando-se afetada pelo manto da preclusão. Não fosse apenas isso, em que pese o tratamento domiciliar não esteja previsto no rol de exigências mínimas estipulado no art. 12 da Lei nº 9.656/98 e as cláusulas gerais contenham previsão de exclusão da cobertura, a patologia em si possui cobertura contratual, com relação à qual não houve negativa da operadora do plano de saúde. Assim, considerando a imprescindibilidade do medicamento, deve prevalecer a cobertura contratual para a patologia, em detrimento da exclusão para tratamento em ambiente domiciliar.*** *Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062112487, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/04/2016)*

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. TROMBOFILIA. AMBIENTE DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA*. 1. Adequação da sentença aos limites da ação, sem que seja reconhecida a sua nulidade, considerando a inexistência de pedido de danos morais. 2.* ***O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora. 3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à operadora de plano de saúde.*** *RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075381418, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017)*

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO USTEQUINUMABE (STELARA) PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE. *Previsto tratamento da moléstia que acomete a autora, pelo contrato celebrado. Abusividade da recusa ao excluir medicamento, sob a alegação de ser de uso domiciliar.* ***No caso de não fornecimento do referido medicamento, o plano de saúde, indiretamente, estaria negando cobertura ao tratamento da moléstia, o que é inadmissível porque previsto em contrato. Ademais, o medicamento vem sendo ministrado pelo médico especialista, em seu consultório médico. Precedente desta Corte. Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente ainda está em tratamento. Podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do contratante.*** *- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. À UNANIMIDADE DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70067800250, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/04/2016)*

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito para confirmar a liminar do evento 3.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da autora, que ora arbitro 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade do feito, o tempo de tramitação de demanda (ação ajuizada em 12/09/2023), a desnecessidade da produção de prova oral e o labor zeloso do profissional – art. 85, § 2º, do CPC.

Ora intimadas as Partes, arquive-se com baixa, com as diligências de praxe em relação às custas e despesas processuais.

Documento assinado eletronicamente por **GERSON MARTINS, Juiz de Direito**, em 12/12/2023, às 10:28:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10051470108v6** e o código CRC **91b5f3dd**.